

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	備/輸血及領用血液輸血作業標準 Prepare / Blood Transfusion and to Requisitioned Blood Transfusion Operating Standards				
編號	A31000-Q02-W-D02	制定者	HD 黃佳玲	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 09 月 03 日
版本/總頁數	第 5.1 版/15 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

護理人員能正確執行備/輸血及領血流程，以確保病人之輸血安全。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

病人欲進行備/輸血，待醫師開立備/輸血醫囑後，如無 ABO、RH type 與 Cross-matching 檢體，HIS 系統會提示醫師開立「ABO、RH type」，並自動開立「輸血前檢驗」，護理人員核對備/輸血醫囑是否有 ABO、RH type 之檢驗，如無，則需請醫生開立醫囑，護理人員於 HIS 系統/護理執行進行核對，手動印出檢驗條碼標籤貼在正確試管上（「ABO、RH type」使用紫頭 CBC 管、「輸血前檢驗」使用血庫專用紫頭管），正確辨識病人後進行採檢，「ABO、RH type」檢驗條碼標籤上顯示為「執行人員」姓名（如圖一）；「輸血前檢驗」檢驗條碼標籤上顯示第一位姓名為「執行人員（主護護理師）」與第二位「覆核人員」姓名（如圖二），採檢完成於檢驗單蓋護理人員確認章後，將檢體及檢驗單核對放入雙層檢體袋，並回到 HIS 系統/護理執行點選執行，再至 HIS 內檢驗檢體傳送系統完成總包、將總包條碼標籤貼於檢體袋上。「輸血前檢驗」醫令需雙重覆核，且覆核人員需為同一人，不符合規定的檢體會依規範進行退檢，須重送檢體。

主題名稱	備/輸血及領用血液輸血作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-D02	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	2/15



(重印) 中山醫學大學附設醫院
大慶院區

(住)醫囑號 112407896



血庫檢驗

患者: 99999998 測試病患五 女 床號: 3T37-1 生日: 1998/1/1 (21 歲又 4 個月) 主治醫師: 鄭人
疹斷碼: 183.0 Malignant neoplasm of ovary

檢查碼	檢查及處置項目	次量	單位	使用頻率	自費	開始時間	檢查地點
11001	A.B.AB.O 血型測定 (試管法)	1	次	ONCE		05/10 09:50	

醫師指示:

11003	RH(D) 型檢查 (試管法)	1	次	ONCE		05/10 09:50	
-------	-----------------	---	---	------	--	-------------	--

檢驗備註: 使用 紫頭CBC管(血型)。

試管使用注意事項:

11003 (RH(D) 型檢查 (試管法)): 特殊狀況時使用手寫標籤, 需有抽
血人手寫簽名, 不接受蓋章

11001 (A.B.AB.O 血型測定 (試管法)): 特殊狀況時使用手寫標
籤, 需有抽血人手寫簽名, 不接受蓋章

Anti -A	Anti -B	Anti -AB	Anti -D	A Cell	B Cell	血型	Check
							M.T



「執行人員」姓名

核對無誤後, 檢驗單上要簽章



圖一「ABO、RH type」檢驗單與檢驗條碼標籤呈現「執行人員」姓名



(重印) 中山醫學大學附設醫院
大慶院區

(住)醫囑號 66171516



血庫檢驗

患者: 99999998 測試病患五 女 床號: 3T37-1 生日: 1998/1/1 (21 歲又 4 個月) 主治醫師: 鄭人
疹斷碼: 183.0 Malignant neoplasm of ovary

檢查碼	檢查及處置項目	次量	單位	使用頻率	自費	開始時間	檢查地點
11004-1	輸血前檢驗	1	U	STAT		10/27 11:35	

醫師指示:

檢驗備註: 使用 血庫專用紫頭管。



第一位姓名為「執行人員(主護護理師)」與第二位「覆核人員」姓名



核對無誤後, 檢驗單上要簽章

圖二「輸血前檢驗」檢驗單與檢驗條碼標籤呈現「執行人員(主護護理師)」與「覆核人員」姓名

護理人員核對備/輸血醫囑, 確認病人姓名、床號、病歷號、「ABO 及 RH Type」後, 由
醫師決定備/輸血或立即領血輸血, 故將分『備血後領血輸血流程』與『立即領血輸血流

主題名稱	備/輸血及領用血液輸血作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-D02	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	3/15

程』分別說明如下：

(一) 備血後領血輸血流程

1. 醫師評估病人病情，考慮手術或治療等原因，預定 72 小時內可能的輸血時，需先申請備血及填寫輸血同意書。由醫師開立備血申請醫囑，請醫師在「領用方式」處勾選備血庫，再由護理人員在 HIS 系統上核對醫囑，醫師在 HIS 系統中的輸血申請作業輸入病人血型、血品、數量、備血原因、輸血方式及預輸血日期，輸血作業的醫囑一開立，若血庫無病人 72 小時內的有效 Cross-matching 檢體時，臨時醫囑會自動開立『輸血前檢驗』，A5 印表機自動印出「血庫檢驗-輸血前檢驗單」，領用狀態顯示「待檢體報到」，提醒護理人員送 Cross-matching 檢體（如圖三）。

住院護理系統 - [使用者: 黃慧琪] [護理執行 Version: 1.42.11.998] [服務專線: 83312 請洽 軟體工程師: 鄭靜如]

查詢患者 離院查核 護理執行 生理監測 護理評估 護理計劃 護理紀錄 醫囑查詢 報告查詢 行政作業 說明(H) 關閉(C)

患者: 22 禁 男 (52 歲又 1 個月) 168cm/52kg 床號: 3036-2 入院時間: 2019/04/25 13:03 醫師: 顏

補充藥物 列印 過敏反應 PCN(-) 存檔 匯入急診輸血醫囑 輸血紀錄 轉床紀錄 產生電子病歷 DNR 防護 磨粉 離開

長期 臨時 PRN 持續 治療 輸血 麻醉

血型: O+ 檢體有效時間: 2019/05/13 10:50:41 顯示紀錄 庫別代碼: A31190 大慶N10綜合科病房(耳鼻喉,口外,整外備血)

醫囑號	過濾器	處方名稱	輸血量	單位	預定時間	核對狀態	執行地點	領用	領用狀態
112423240	☐	Leucocyte-Poor RBC	2,000	U	05/11 08:00		N10		
112423239	☐	Leucocyte-Poor RBC	2.00	U	05/10 10:50		N10		備血庫

待檢體報到

圖三

2. 曾經送過 Cross-matching 檢體時，檢體有效時間會出現在 HIS 系統/護理執行/輸血的介面上，若 Cross-matching 檢體超過三天或不夠，則 HIS 系統會顯示需抽 Cross-matching 檢體送檢（如圖四）。護理人員備妥抽血用物，協同另一位護理人員或醫師至病人單位，以兩種以上確認病人身分方式抽血，請參考 A31000-Q02-W-A09 病人辨識作業標準。

主題名稱	備/輸血及領用血液輸血作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-D02	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	4/15

中山醫學大學附設醫院				27906415
備血申請(常規)				[重印]
患者: 8 [redacted] 宋張 [redacted] 女 1 [redacted] (75 歲又 7 個月) 3215-2 入院時間: 2012/08/14 13:34 醫師: 連 [redacted]				
診斷碼: 599.0 Urinary tract infection				
預備血品	患者血型: B+	備血血型: B+		
血品碼	血品名稱	數量	適應症	
93001	Packed RBC	2U	長期慢性貧血病人Hb<8g/dl	
備註:				
				
抗體普檢				
檢驗碼	驗證名稱	數量	備註	
11004-1	輸血前檢驗	1		

圖四 需抽 Cross-matching 檢體送檢

- 完成備血程序欲領血輸注時，由醫師開立備血領回輸注之醫囑，護理人員進入 HIS 系統/護理執行/輸血核對狀態處點選「正確」，並輸入「執行地點」，是否領用欄處選擇「是」→領血作業輸入「領血前生命徵象」(如圖五)。血庫接到電腦資訊系統顯示通知領血，即使用 Cross-matching 檢體進行合血，合血完成後 HIS 系統/護理執行的輸血領用狀態會呈現「待領血」(如圖六)，A5 印表機會自動印出領血通知單。非假日時間(星期一至星期五 8:00 至 24:00)系統會主動傳訊息至派遣中心請傳送人員至血庫領血，HIS 系統/護理執行的輸血領用狀態顯示『已出庫』，傳送人員會直接將該血品送到輸血執行單位，假日時間領血改以電話通知傳送人員至單位拿領血通知單後至血庫領血。

主題名稱	備/輸血及領用血液輸血作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-D02	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	5/15

住院護理系統 - [使用者:] [護理執行 Version: 1.44.0.133] [服務專線: *200 接通後再按 27302 請洽 軟體工程師:]

查詢患者 護理查核 護理執行 生理監測 護理評估 護理計劃 護理紀錄 醫囑查詢 報告查詢 行政作業 說明(H) 關閉(C)

患者: 83 黃 男 1948/09/20(73 歲又 9 個月) 163cm/64.75kg 床號: 2936-3 入院時間: 2022/07/10 21:59 醫師: 林

補充藥物 列印 過敏反應 PCN(-) 存檔 匯入急診輸血 輸血紀錄 骨髓移植紀錄 轉床紀錄 防護 預防跌倒 檢查排程 離開

長期 臨時 PRN 持續 化療 輸血 麻醉

血型: O+ 檢體有效時間: 2022/07/19 07:28:53 顯示紀錄 庫別代碼: A31140 大慶骨科暨眼科、一般醫學外科病房

備血

醫囑號	濾	照	處方名稱	血型	輸血量	單位	預定時間	核對狀態	執行地點	領用	領用狀態
161112545	☐	☐	Leucocyte-Poor RBC	O+	2.000	U	07/19 07:32	正確	HD	☒	☐

醫師指示:

輸血 條碼: 血袋號碼 簽收 核對 清除

技術費及附帶材料項目 - 新增/修改

問題 您是否要領用?

是(Y) 否(N)

領血前生命徵象體溫:

時間: 2022/07/19 08:07

體溫: °C

脈搏: 次/分

呼吸: 次/分

血壓: / mmHg

確定(O) 取消(C)

血袋資訊 輸血反應: 有 血品名稱: 血袋血型: 脈搏: 次/分 脈搏: 次/分

圖五 領血前生命徵象

主題名稱	備/輸血及領用血液輸血作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-D02	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	6/15

門診護理系統 - [使用者: 黃] [護理執行 Version: 1.42.11.998] [服務專線: 83312 請洽 軟體工程師: 鄭靜如]

患者清單 護理執行 護理評估 護理衛教 醫囑查詢 報告查詢 說明(H) 關閉(C)

患者: 20 張 女 19 歲又 3 個月 05/10 下午 診間: 320 320 診 (汝川大樓3F) 診號: 16 醫師: 洪

補充藥物 列印 過敏反應 存檔 輸血紀錄 產生電子病歷 DNR 防護 檢查排程 訪視時間 雲端藥歷 其他 磨粉 離開

長期 臨時 PRN 持續 化療 輸血 麻醉

血型: B+ 檢體有效時間: 2019/05/13 19:33:36 顯示紀錄 庫別代碼: A31030 大慶門診護理站

備血

醫囑號	過濾器	處方名稱	輸血量	單位	預定時間	核對狀態	執行地點	領用	領用狀態
112444161	☐	Leucocyte-Poor RBC	2.000	U	05/10 19:33	正確	洗腎室	是	血庫合血中

↓

門診護理系統 - [使用者: 黃] [護理執行 Version: 1.42.11.998] [服務專線: 83312 請洽 軟體工程師: 鄭靜如]

患者清單 護理執行 護理評估 護理衛教 醫囑查詢 報告查詢 說明(H) 關閉(C)

患者: 20 張 女 19 歲又 3 個月 05/10 下午 診間: 320 320 診 (汝川大樓3F) 診號: 16 醫師: 洪

補充藥物 列印 過敏反應 存檔 輸血紀錄 產生電子病歷 DNR 防護 檢查排程 訪視時間 雲端藥歷 其他 磨粉 離開

長期 臨時 PRN 持續 化療 輸血 麻醉

血型: B+ 檢體有效時間: 2019/05/13 19:33:36 顯示紀錄 庫別代碼: A31030 大慶門診護理站

備血

醫囑號	過濾器	處方名稱	輸血量	單位	預定時間	核對狀態	執行地點	領用	領用狀態
112444161	☐	Leucocyte-Poor RBC	2.000	U	05/10 19:33	正確	洗腎室	是	待領血

↓

醫師指示:

輸血

條碼:

血袋號碼

☐ 0841108347

☐ 0801108349

[大慶] 領血單號: 112444161

領血單 (請持本單到核醫大樓二樓血庫領血)

患者: 20 張 女 19 歲又 3 個月 診間: 320 320 診 (汝川大樓3F) 醫師: 洪

備血原因: 失血超過全身血量的15%(500-1000cc) 患者血型: B+ 備血血型: B+

血品碼	血品名稱	數量	醫師指示	備註
93019	Leucocyte-Poor RBC	2U		需冷藏

簽收人員:

圖六 護理執行的輸血領用狀態

4. 醫囑開立兩筆 PRBC 2U，護理人員於輸血介面下先領用一筆（如圖七）；第一筆輸血快完成時再領用另一筆，禁止領用 4U 造成棄血或退血的異常。

住院護理系統 - [使用者: 黃慧琪] [護理執行 Version: 1.42.11.998] [服務專線: 83312 請洽 軟體工程師: 鄭靜如]

查詢患者 離院查核 護理執行 生理監測 護理評估 護理計劃 護理紀錄 醫囑查詢 報告查詢 行政作業 說明(H) 關閉(C)

患者: 22 蔡 男 52 歲又 1 個月 168cm/52kg 床號: 3036-2 入院時間: 2019/04/25 13:03 醫師: 顏

補充藥物 列印 過敏反應 PCN(C) 存檔 匯入急診輸血醫囑 輸血紀錄 轉床紀錄 產生電子病歷 DNR 防護 磨粉 離開

長期 臨時 PRN 持續 化療 輸血 麻醉

血型: O+ 檢體有效時間: 2019/05/13 10:50:41 顯示紀錄 庫別代碼: A31190 大慶N10綜合科病房(耳鼻喉,口外,整外)

備血

醫囑號	過濾器	處方名稱	輸血量	單位	預定時間	核對狀態	執行地點	領用	領用狀態
112423240	☐	Leucocyte-Poor RBC	2.000	U	05/11 08:00		N10		
112423239	☐	Leucocyte-Poor RBC	2.00	U	05/10 10:50		N10		備血庫

↑ 領血順序

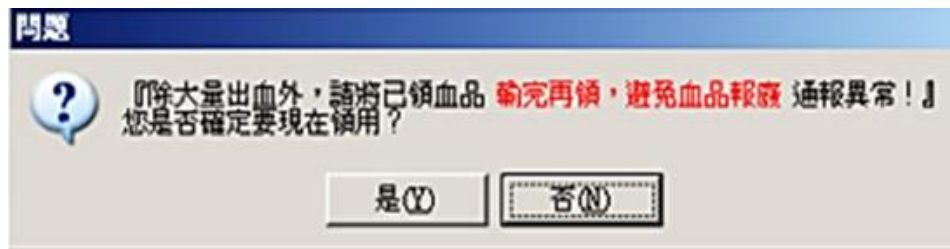
圖七 先領用一筆，輸血快完成時再領用另一筆

主題名稱	備/輸血及領用血液輸血作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-D02	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	7/15

(二) 立即領血輸血流程

1. 醫師開立立即領血輸血醫囑後，醫師在 HIS 系統中的輸血申請作業輸入病人血型、血品、數量、輸血原因、輸血方式及輸血日期，若血庫無病人 72 小時內的有效 Cross-matching 檢體時，臨時醫囑會自動開立『輸血前檢驗』，A5 印表機會自動印出「血庫檢驗-輸血前檢驗」單，領用狀態顯示「待檢體報到」，提醒護理人員送 Cross-matching 檢體。護理人員需進入 HIS 系統/護理執行/輸血核對狀態處需點選「正確」，並輸入「執行地點」，是否領用欄處選擇「是」。血庫接到電腦資訊系統顯示通知領血，並收到 Cross-matching 檢體後則會進行合血，合血完成後 HIS 系統/護理執行的輸血領用狀態會呈現「待領血」，A5 印表機會自動印出領血通知單，非假日時間（星期一至星期五 8：00 至 24：00）系統會主動傳訊息至派遣中心請傳送人員至血庫領血，HIS 系統/護理執行的輸血領用顯示『已出庫』，傳送人員會直接將該血品送到輸血執行單位。假日時間領血改以電話通知傳送人員至單位拿領血通知單後至血庫領血。
2. 曾經送過 Cross-matching 檢體時，檢體有效時間會出現在 HIS 系統/護理執行/輸血的介面上，若 Cross-matching 檢體超過三天或不夠，則 HIS 系統會顯示需抽 Cross-matching 檢體送檢。護理人員備妥抽血用物，協同另一位護理人員或醫師至病人單位，以兩種以上確認病人身分方式抽血，請參考 A31000-Q02-W-A09 病人辨識作業標準。
3. 血品領回後由主護在 HIS 系統上簽收，核對「血袋」及「領血通知單」上之姓名、病歷號、床號、血型、血品、數量、血袋號碼及是否領用過濾器，核對無誤後在領血單上簽名，並註明領血時間。
4. 當第一筆輸血醫囑領用後未超過 30 分鐘就領用第二筆血品時，護理系統將出現『除大量出血外，請將已領血品輸完再領，避免血品報廢通報異常!』，您是否確定要現在領用的提示視窗，以提醒避免血品報廢。

主題名稱	備/輸血及領用血液輸血作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-D02	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	8/15



5. 緊急輸血時的相關程序，請詳見護理部護理作業常規 A31000-Q02-W-D03 緊急輸血作業標準。

6. 注意事項：

- (1) 備/輸血前醫師應先向病人解釋必須備/輸血之原因。
- (2) 備/輸血時須注意病人是否曾經發生輸血過敏史（如：兩次以上的發冷、發燒反應等），病人如有輸血之過敏史，請提醒醫師可以使用去白血球過濾器（註：此屬醫師的專業判斷）。
- (3) 備血申請單自開單起 72 小時內有效，超過三天未領用申請單自動失效。超過三天的備血單無法領用輸注，如有需要輸血請醫師重新開單與重新抽血 cross-matching 檢體送檢。
- (4) 輸用含紅血球成份之血品(WB，LP-RBC，Washed RBC)：一定須抽 cross-matching 檢體，除非該病人有 3 天內的 cross-matching 檢體。輸用不含紅血球成份之血品(F.F.P/F.P/Platelet conc./PPH/Cryo.)：如該病人有本院之輸血電腦記錄，則無須抽 cross-matching 檢體。
- (5) 除了手術備血用途外，血庫不接受血小板、血漿類血品(FFP、FP、CRYO)的備血。
- (6) RH 陰性血品經血庫發出，可安全輸給 RH 陽性病人。Platelet conc.(PPH)原則上儘量符合 ABO 血型相容性，但緊急時可互相替代。冷凍沉澱品(Cryo.)輸注，不用符合 ABO 血型，所有血型皆可接受。
- (7) 領血人員領血要帶冰桶，冰寶上面要墊隔冷紙板或其他物品（如包布等），但只領血小板是不需要冰寶。若一次放入多種血品時（含血小板），需將血小板與冰寶隔開，避免血小板因接觸冰寶而失去療效。

主題名稱	備/輸血及領用血液輸血作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-D02	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	9/15

(8) 血品出庫後到輸注完成的時間不可大於 4 小時，否則將增加感染的危險。領回之血品不存放於護理站冰箱；血品若當下因故無法及時輸注，請於領回 30 分鐘內，盡速執行血品退回，則此血品可有效利用，避免浪費。所有『血品退回』之血品，除了符合 30 分鐘退血條件予與退血外，其餘不符合條件者則棄血處理。

(9) 血液領回後因病情改變而未輸注者，30 分鐘內可依程序申請退血，紅血球類血品需為未加熱；血漿類血品解凍後不接受退血申請。

備註：

A. 新鮮冷凍血漿(Fresh Frozen Plasma)簡寫為 F.F.P。

B. 冷凍血漿(Frozen Plasma)簡寫為 F.P。

C. 血小板濃厚液(Platelet Concentrates)簡寫為 Pl.conc。

D. 分離術血小板(Platelet Pheresis)簡寫為 PPH。

E. 冷凍沉澱品(Cryoprecipitate)簡寫為 Cryo.。

(10) 『有輸血反應，停止輸血』之血品退回流程，請詳見護理部護理作業常規 A31000-Q02-W-D06 血品退回作業標準。

A. 需完成輸血後生命徵象回報。

B. 需勾選輸血反應類型。

C. 在勾選『有輸血反應，停止輸血』後才退回血品。

(11) 當全院 HIS 系統當機時，啟動護理部全院電腦系統中斷服務住院病人緊急應變作業標準後，「ABO、RH type」試管上須貼黃色的「血型專用標籤」，「輸血前檢驗」試管上需貼紅色的「輸血專用標籤」，一律手寫填入資料，不可以蓋章代替。

(三) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

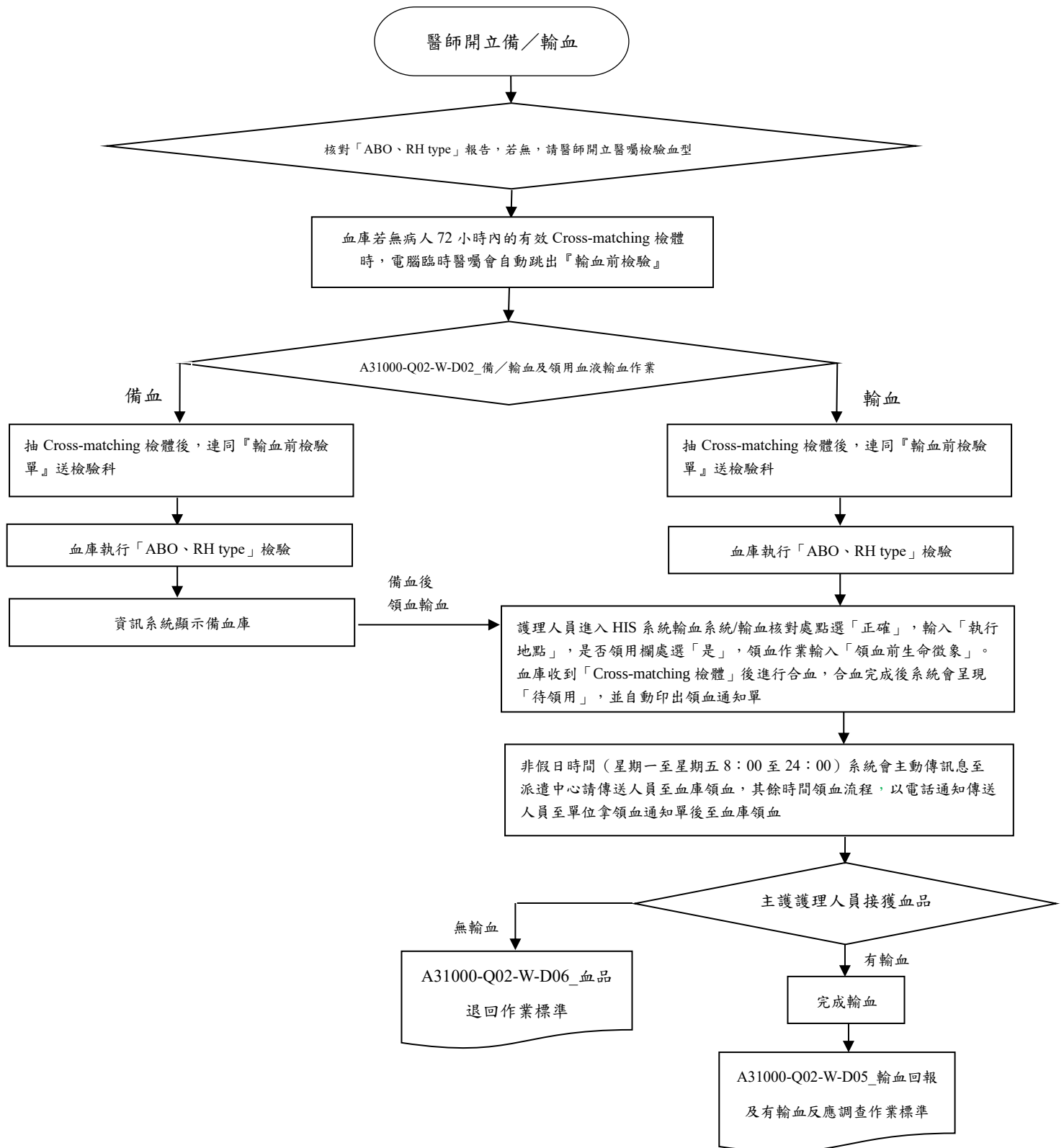
主題名稱	備/輸血及領用血液輸血作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-D02	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	10/15

四、使用表單

(略)

主題名稱	備/輸血及領用血液輸血作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-D02	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	11/15

五、流程圖



主題名稱	備/輸血及領用血液輸血作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-D02	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	12/15

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	備/輸血及領用血液輸血作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-D02	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	13/15

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定。	98 年 05 月 31 日 通過護理部照護 標準委員會。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.11.04	2.1	因應病歷電子化與血庫再次確認無須更改作業標準。	100 年 11 月 04 日 過護理部照護標 準委員會。
101.06.07	2.2	新增領血後未馬上輸注時保存注意事項。	101 年 06 月 07 日 通過各科協調會 會議制定。
101.10.03	3.0	整合 D01「輸血作業標準」與 D02「輸血時領用血液作業標準」與 D04「領血作業標準」主題名稱改為「備/輸血及領用血液輸血作業標準」。	101 年 10 月 03 日 通過護理部照護 標準委員會。
102.01.17	3.1	注意事項(11)新增『有輸血反應，停止輸血』之血品退回流程。(1)須完成輸血後生命徵象回報。(2)需勾選輸血反應類型。(3)在勾選『有輸血反應，停止輸血』後才退回血品。	102 年 01 月 17 日 通過護理部照護 標準委員會。
102.02.26	4.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.12.03	4.1	新增說明內容： 病人輸血醫囑開立兩筆 PRBC 2U 請護理人員於輸血介面下先領用一筆第一筆輸血快完成時再領用另依筆避免一次領用 4U 造成棄血或退寫的異常。當第一筆輸血醫囑領用後未超過 30 分鐘就領用第二筆血品時，護理系統將出現提示視窗『除大量出血外，請將已領血品輸完再領避免血品報廢通報異常』。	102 年 12 月 03 日 通過護理部照護 標準委員會。
103.06.03	4.2	說明內容修改：避免一次領用改為禁止領用 4U 造成棄血或退血的異常。	103 年 06 月 03 日 護理部照護標準 委員會通過。
103.06.30	4.3	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	

主題名稱	備/輸血及領用血液輸血作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-D02	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	14/15

修正日期	版本	修正說明	備註
104.06.02	4.4	第三項說明及第五項流程圖內容之 HIS2008 一律統稱為 HIS 系統。	104 年 06 月 02 日 護理部照護標準委員會通過。
105.06.07	4.5	第三項說明內容部份修辭及更正錯別字。	105 年 06 月 07 日 護理部照護標準委員會通過。
105.12.06	4.6	第三項第(二)目之 8(9)刪除：血品若不能立即輸注應置於冰箱冷藏(2~8℃)。改為~血品若當下因故無法及時輸注，請於領回 30 分鐘內，盡速執行血品退回，則此血品可有效利用，避免浪費，當血品領回護理站超過 4 小時或冷凍沉澱品超過 6 小時，未給病人輸注就應執行血品退回，病房冰箱不應儲存血品。	105 年 12 月 06 日 護理部照護標準委員會通過。
106.06.05	4.7	第三項第(二)目之 8(9)刪除：當血品領回護理站超過 4 小時或冷凍沉澱品超過 6 小時，未給病人輸注就應執行血品退回，病房冰箱不應儲存血品。增加說明內容：1.領回之血品不存放於護理站冰箱，立刻輸；2.所有『血品退回』之血品，除了符合 30 分鐘退血條件予與退血外，其餘不符合條件者則棄血處理。 依據 105 年第三次輸血委員會(105.12.09)決議，公告之『血品保存、傳送、退血與報廢之作業程序』內容節錄自檢驗科血庫組檢驗後流程標準作業程序最新版文件(CSHL-SOP(BBK)-050701)。	106 年 06 月 05 日 護理部照護標準委員會通過。
107.06.04	4.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.06.06	4.8	1. 血型及輸血前檢驗標籤已於 107.07.02 實行資訊化，故予修訂第三項內文及增加圖示說明。 2. 第三項第三日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議通過;108 年 06 月 12 日護理長會議通過;108 年 06 月 18 日督導會議通過公布。
109.06.04	4.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	備/輸血及領用血液輸血作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-D02	版本	第 5.1 版	頁碼/總頁數	15/15

修正日期	版本	修正說明	備註
110.08.03	4.9	1. 第一、三項內文修飾。 2. 增加圖一、圖二說明。	110 年 07 月 08 日照護標準組會議通過;110 年 07 月 14 日護理長會議通過;110 年 08 月 03 日督導會議通過公布。
111.06.02	4.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.07.04	5.0	1. 第三項第一目之 3.增加領血作業輸入「領血前生命徵象」(如圖五)。 2. 第五項流程圖增加內文說明。	112 年 06 月 08 日照護標準組會議通過;112 年 06 月 14 日護理長會議通過;112 年 07 月 04 日督導會議通過公布。
113.04.30	5.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.09.03	5.1	第三項說明新增總包流程。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過;113 年 08 月 14 日護理長會議通過;113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。
114.06.05	5.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	